

Parkinsonismo y Demencias

1. Introducción y relevancia clínica

El **parkinsonismo** y las **demencias** constituyen dos de las principales causas de **discapacidad neurológica crónica** en adultos mayores.

Ambas condiciones comparten mecanismos degenerativos del sistema nervioso central y, en muchos casos, pueden coexistir o evolucionar conjuntamente.

El **parkinsonismo** se define como el conjunto de signos caracterizados por **bradicinesia, rigidez, temblor de reposo y alteración de la postura y la marcha**. Su forma más frecuente es la **enfermedad de Parkinson (EP)** idiopática, pero existen causas secundarias (fármacos, ACV, trauma, otras enfermedades neurodegenerativas).

Las **demencias**, por su parte, representan un deterioro progresivo de las funciones cognitivas que interfiere con la vida diaria, siendo la **enfermedad de Alzheimer** la causa más común, seguida de la **demencia vascular** y la **demencia con cuerpos de Lewy**.

En Chile, la prevalencia de demencia en mayores de 65 años alcanza un **7–8%**, y la de Parkinson alrededor de **1–2%**. Ambas enfermedades son altamente relevantes en el **EUNACOM** por su frecuencia, sus características clínicas definitorias y las decisiones terapéuticas que el médico general debe conocer.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Parkinsonismo

El parkinsonismo resulta de la **degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta**, que proyectan hacia el **estriado (putamen y caudado)**.

Esta pérdida dopaminérgica altera el equilibrio entre vías inhibitorias y excitatorias de los **ganglios basales**, lo que lleva a **bradicinesia y rigidez**.

En la **enfermedad de Parkinson idiopática (EPI)**, el proceso es neurodegenerativo y se asocia a la acumulación intracelular de **cuerpos de Lewy**, formados por agregados de **alfa-sinucleína**.

En otras formas de parkinsonismo secundario, la disfunción dopaminérgica puede ser consecuencia de **fármacos antidopaminérgicos (metoclopramida, haloperidol)**, **lesiones vasculares múltiples** o **trastornos neurodegenerativos atípicos**.

2.2. Demencias

Las demencias se originan por **pérdida progresiva de neuronas corticales y subcorticales**, lo que compromete las funciones cognitivas superiores: **memoria, lenguaje, juicio, orientación y comportamiento**.

- **Demencia tipo Alzheimer (DTA):** acumulación de **placas de beta-amiloide** y **ovillos neurofibrilares de tau** en corteza cerebral e hipocampo.
 - **Demencia vascular:** lesiones isquémicas múltiples o infartos lacunares.
 - **Demencia con cuerpos de Lewy:** inclusiones de alfa-sinucleína corticales y subcorticales (relacionada con Parkinson).
 - **Demencia frontotemporal:** degeneración focal de lóbulos frontales y temporales, con alteraciones conductuales marcadas.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Enfermedad de Parkinson (EP)

El diagnóstico es **clínico**, basado en los siguientes **cuatro signos cardinales**:

1. **Bradicinesia:** lentitud en el inicio y ejecución de movimientos (dificultad para abotonarse, escribir o caminar).
2. **Rigidez:** aumento del tono muscular con resistencia al movimiento pasivo (“rueda dentada”).
3. **Temblor de reposo:** 4–6 Hz, asimétrico, “en cuenta monedas”, que desaparece con el movimiento voluntario.
4. **Inestabilidad postural:** alteración del equilibrio y marcha festinante (pasos cortos, sin balanceo de brazos).

Otros síntomas: hipomimia facial, voz monótona, micrografía, hiposmia, depresión, trastornos del sueño y estreñimiento.

Evolución: lenta y progresiva; afecta inicialmente un hemicuerpo, extendiéndose bilateralmente con los años.

Comentario EUNACOM:

El Parkinson idiopático siempre presenta **respuesta clínica significativa a levodopa**, lo que ayuda a diferenciarlo de otros parkinsonismos.

3.2. Parkinsonismos secundarios o atípicos

- **Inducido por fármacos:** antipsicóticos, metoclopramida, flunarizina. Suele ser simétrico y sin temblor.
 - **Vascular:** ACV múltiples en ganglios basales, inicio brusco, marcha lenta y rigidez.
 - **Parkinsonismo plus:** degeneraciones multisistémicas (atrofia multisistémica, PSP, degeneración corticobasal), con escasa respuesta a levodopa.
-

3.3. Síndromes demenciales más frecuentes

A. Demencia tipo Alzheimer (DTA)

- **Inicio insidioso**, con afectación inicial de la **memoria reciente**.
- Evoluciona a pérdida de orientación, lenguaje y juicio.
- Conserva conducta social en etapas tempranas.
- **Fase avanzada:** dependencia total, mutismo, rigidez.

B. Demencia vascular

- Curso **escalonado**, asociado a **eventos isquémicos previos** o factores vasculares (HTA, DM, dislipidemia).
- Déficit focal neurológico y alteraciones de la marcha.
- Compromete atención y velocidad de procesamiento antes que la memoria.

C. Demencia con cuerpos de Lewy

- **Fluctuaciones cognitivas, alucinaciones visuales vívidas y parkinsonismo espontáneo.**
- Hipersensibilidad a antipsicóticos (pueden empeorar el cuadro).

D. Demencia frontotemporal

- Alteraciones conductuales (desinhibición, apatía, impulsividad) con lenguaje afectado tempranamente.
 - Más frecuente en adultos jóvenes (50–65 años).
-

3.4. Diagnóstico diferencial general

- **Depresión (pseudodemencia):** quejas cognitivas con ánimo deprimido; responde a antidepresivos.
- **Delirium:** confusión aguda reversible por causas médicas (infecciones, fármacos, deshidratación).
- **Hipotiroidismo, déficit de B12, sífilis, VIH:** causas tratables.

Comentario EUNACOM:

En los casos clínicos, si el paciente presenta deterioro progresivo de memoria y orientación con examen neurológico normal, la respuesta más probable es **Demencia tipo Alzheimer**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Enfermedad de Parkinson

El diagnóstico es **clínico**, sin test confirmatorio específico.

Criterios diagnósticos (UK Parkinson's Disease Society Brain Bank):

1. **Bradicinesia** obligatoria, más uno de los siguientes:
 - Rigidez.
 - Temblor de reposo 4–6 Hz.
 - Inestabilidad postural no explicada por otras causas.
2. Exclusión de parkinsonismos secundarios.
3. Respuesta clara a levodopa.

Exámenes complementarios:

- TAC o RM cerebral para descartar lesiones estructurales.
 - SPECT con DaTSCAN (si diagnóstico incierto, no de rutina).
-

4.2. Demencias

Estudio básico inicial (MINSAL, 2023):

- **Examen físico y neurológico completo.**
 - **Minimental State Examination (MMSE) o Montreal Cognitive Assessment (MoCA)** para evaluación cognitiva.
 - **Laboratorio general:** hemograma, TSH, B12, glicemia, VDRL, función renal y hepática.
 - **Neuroimagen (RM o TAC):** descartar causas estructurales (tumores, hematomas, hidrocefalia).
 - **Evaluación funcional:** actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
-

5. Tratamiento (según MINSAL y guías internacionales 2023–2024)

5.1. Enfermedad de Parkinson

A. Tratamiento farmacológico:

- **Levodopa + carbidopa o benserazida:** fármaco de elección.
 - Dosis inicial: 100/25 mg c/8 h, ajustar progresivamente.
 - Efectos secundarios: discinesias, fluctuaciones motoras.
- **Agonistas dopaminérgicos:** pramipexol, ropinirol; útiles en fases iniciales o jóvenes.
- **Inhibidores de la MAO-B:** selegilina, rasagilina.

- **Amantadina:** mejora discinesias leves.
- **Anticolinérgicos:** útiles en temblor predominante, pero limitados en ancianos.

B. Manejo no farmacológico:

- Kinesioterapia y fisioterapia.
- Fonoaudiología para voz y deglución.
- Apoyo psicológico y educación familiar.

C. Tratamientos avanzados:

- **Estimulación cerebral profunda (DBS):** en casos refractarios con buena respuesta inicial a levodopa.
-

5.2. Demencias

A. Tratamiento farmacológico sintomático:

- **Inhibidores de colinesterasa:** donepezilo, rivastigmina, galantamina.
 - Indicados en DTA leve a moderada y en demencia con cuerpos de Lewy.
- **Memantina (antagonista NMDA):** para DTA moderada a severa o combinada.

B. Manejo conductual y ambiental:

- Estructurar rutinas, mantener entorno familiar estable.
- Estimulación cognitiva y social.
- Evitar sujeciones innecesarias o fármacos sedantes.

C. Control de comorbilidades:

- Tratar HTA, DM, dislipidemia y depresión.
- En demencia vascular: aspirina y estatinas según perfil.

D. Educación del cuidador:

Fundamental para prevenir síndrome del cuidador y asegurar adherencia.

6. Complicaciones

Enfermedad de Parkinson:

- **Fluctuaciones motoras (“on-off”).**
- **Discinesias inducidas por levodopa.**
- **Depresión y deterioro cognitivo.**
- **Trastornos deglutorios (riesgo aspirativo).**
- **Caídas y fracturas.**

Demencias:

- **Desnutrición, úlceras por presión, infecciones.**
 - **Síndromes confusionales agudos.**
 - **Alteraciones conductuales (agitación, psicosis).**
 - **Dependencia total en etapas avanzadas.**
-

7. Pronóstico

Ambas son **enfermedades crónicas y progresivas**.

- **Parkinson:** sobrevida promedio de 15–20 años; la respuesta terapéutica inicial es buena, pero surgen complicaciones motoras y cognitivas.
- **Demencias:** curso inexorablemente progresivo, con deterioro funcional completo en fases avanzadas.

El abordaje multidisciplinario (neurología, kinesiología, psicología, geriatría) mejora la calidad de vida y retrasa institucionalización.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. La **bradicinesia** es el signo cardinal del Parkinson; sin ella, no hay diagnóstico.
2. El **temblor de reposo asimétrico** es característico del Parkinson idiopático.
3. **Respuesta positiva a levodopa** distingue la EP de los parkinsonismos secundarios.
4. En demencia tipo Alzheimer, la **memoria reciente** es la función más precozmente afectada.
5. La **demencia vascular** cursa en escalones y con signos focales.
6. Las **alucinaciones visuales + parkinsonismo** orientan a **demencia con cuerpos de Lewy**.
7. En EUNACOM, suelen preguntar qué fármaco usar y cuál evitar en ancianos (anticolinérgicos → contraindicado).

Errores comunes:

- Diagnosticar Parkinson sin bradicinesia.
- Usar levodopa precozmente en pacientes jóvenes sin considerar agonistas dopaminérgicos.
- Suspender abruptamente la levodopa (riesgo de síndrome neuroléptico maligno).
- Tratar demencia vascular con donepezilo sin control de factores vasculares.
- No descartar causas reversibles de deterioro cognitivo (B12, TSH).

9. Resumen final (6 ideas clave)

1. El **parkinsonismo** es un síndrome motor caracterizado por **bradicinesia, rigidez y temblor de reposo**, siendo la **enfermedad de Parkinson** su causa más frecuente.
2. El diagnóstico de Parkinson es **clínico** y la **respuesta a levodopa** es diagnóstica y terapéutica.

3. Las **demencias** implican deterioro progresivo de funciones cognitivas, con el **Alzheimer** como la forma más común.
4. El estudio de demencias incluye **evaluación cognitiva, exámenes básicos y neuroimagen**.
5. El tratamiento combina **manejo farmacológico, rehabilitación y soporte familiar**.
6. En EUNACOM, las preguntas suelen centrarse en diferenciar **Parkinson idiopático vs parkinsonismo secundario**, y **Alzheimer vs demencia vascular**.